EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 89966
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-08-05 09:41:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: VILMA DE LAS MERCEDES SEPULVEDA ROMERO			RUN	: 8.159.080-K
F.Nac	: 15-06-1956	Edad	: 68 AÑOS, 1 MES	Género	: Femenino
Dirección	: POB. NUEVA ESPERANZA MARTA BRUNET CASA 24			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 992550760		
Fecha Ingreso	: 2024-08-01	Fecha Egreso	: 2024-08-05 09:41:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Pielonefritis aguda
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Femenina De 68 Años De Edad Con Antecedentes Mórbidos De Hta, Espondilolisis En Tto Regular. Sin Alergia Conocidas
Quien Acude El Dia 30/07 Por Cuadro De Nauseas, Dolor Lumbar Y Orinas Turbias, Es Evaluada Se Pesquisa Itu Probable Pna, Con Parámetros Inflamatorios Elevados, Orina Infecciosa, Se Indica Hospitalización Sin Embargo Paciente Rechaza Por Razone Personales Y Se Indica Ceftriaxona Ambulatoria.
El Dia 01/8 Hoy Acude Nuevamente Por Persistir Febril, Con Nauseas, Mareos, Dolor Abdominal Y Lumbar Urocultivo + Con E. Coli Multisensible Con Alza PCR 207 LACTATO 1.6, NA 145, K 3.1, CL 106, GB 5500 SEG 57% PROCALCITONINA 6.9. Por Lo Que Es Evaluada Y Se Decide Su Ingreso
Se rescata Pielotac: Leve hidronefrosis izquierda, sin evidencia de litiasis. el Cambio de calibre se localiza en ureter distal adyacente al anexo ipsilateral que presenta una lesión calcificada. Se acompaña de edema perirrenal ipsilateral. considerar proceso inflamatorio - infecciosos.
Se administra tto atb por 5 dias con fanca ,ejoroa con paramewtro inflamtorios bajos.
Evolucionado favorablemente, sin fiebre, sin nauseas. tórax expansible mp presente sin agregados, rr2ts, abdomen plano blando puño percusión negativa. eeii sin edema, neurologico vigil orientado glagsow 15 ptos sin focalización neurológica. En condiciones de lata con Hodom.

PLAN DE MANEJO:

ALTA CON HODOM HASTA COMPLETAR TO ATB
CONTINUAR CON TTO CRÓNICO

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo Relativo
2. Regimen Liviano Hiposodico tomar abundantes liquidos
3. Omeprazol 20mg Vo Dia
4. Ceftriaxona 2 Gr Ev Cada 24 Horas por ev por 5 dias
5. Paracetamol 1 Gr vo Cada 8 Horas
6. Sertralina 50mg Vo Dia

7. Zolpidem 10mg 1 Comp Noche
8. Enalapril 10mg 1 Comp Vo Dia
9. Tamsulosina 0,4 mg dia vo
10. Exámenes control en 72 horas con urocultivo

EXÁMENES Y RESULTADOS

Procalcitonina : 0,71
Proteina C Reactiva : 31,3
Creatinina : 0,70 mg/dl
Clearence Calculado(MDRD) : 83,21

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO